

Sygnały ostrzegawcze

Twoja osobista lista wczesnych objawów manii i depresji. Im wcześniej rozpoznasz, tym mniejsza interwencja wystarczy — najczęściej wystarczy modyfikacja zachowania, bez zmiany leków.

CZAS: 45 min — wypełnienie z bliskimi Aktualizacja co 6 miesięcy

ŹRÓDŁO: Lam i wsp. (2003); Perry i wsp. (1999, BMJ)

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij tę kartę, gdy jesteś w eutymii (równowadze). Każdy epizod manii i depresji ma **prodromy** (sygnały zwiastunowe) — drobne zmiany pojawiające się 1–4 tygodnie przed pełnym epizodem. Lista Twoich osobistych prodromów + plan działania dla każdego poziomu nasilenia. Wypełnij z osobą bliską, która zauważa zmiany w Tobie wcześniej niż Ty sam/a.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W kontrolowanym badaniu klinicznym Perry i wsp. (1999, *BMJ*) pacjenci ChAD nauczeni rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych mieli **30% mniej epizodów manii** w ciągu 18 miesięcy. Mechanizm: *okno interwencyjne*. Między prodromem a pełnym epizodem są zwykle 2–4 tygodnie, w których mała korekta (sen, kontakt z lekarzem, redukcja stymulacji) zapobiega hospitalizacji. To okno znika, gdy objawy są już pełnoobjawowe — wtedy wgląd jest zaburzony.

01 → Moje sygnały manii / hipomanii

Zaznacz te, które pojawiły się przed wcześniejszymi epizodami. Dodaj własne z prawej kolumny.

TYPOWE PRODROMY MANII

- ☐ Mniej snu, a więcej energii
- ☐ Pomysły lecą szybciej, niż mogę je wypowiedzieć
- ☐ Mówię szybciej, głośniejsze, więcej
- ☐ Czuję się wyjątkowo dobrze, „w formie”
- ☐ Wzrost libido, flirt, nowe znajomości
- ☐ Wydaję pieniądze impulsywnie
- ☐ Wiele nowych planów, projektów
- ☐ Drażliwość, nietolerancja na frustrację
- ☐ Słuchanie głośnej muzyki, dużo kawy
- ☐ Mniej potrzebuję jedzenia

MOJE OSOBISTE — WPISZ

02 ↓ Moje sygnały depresji

TYPOWE PRODROMY DEPRESJI

- ☐ Sen się wydłuża, ciężko wstać
- ☐ Spadek energii i motywacji
- ☐ Wycofuję się — odwołuję spotkania
- ☐ Ruminacje — myśli krążą wokół problemów
- ☐ Bardziej krytyczny/-a wobec siebie
- ☐ Anhedonia — to, co cieszyło, już nie cieszy
- ☐ Spadek zainteresowania higieną osobistą
- ☐ Zmiana apetytu (wzrost lub spadek)
- ☐ Płaczliwość, drażliwość
- ☐ Spowolnienie myślenia, decyzji

MOJE OSOBISTE — WPISZ

03 ☉ Plan działania — sygnały manii

POZIOM 1 · 1–2 SYGNAŁY, ŁAGODNE

Zwiększ sen do 8–9 h. Odstaw kofeinę i alkohol. Powiedz osobie bliskiej. Zmniejsz aktywność wieczorną. Sprawdź regularność leków. Notuj wykres nastroju codziennie.

POZIOM 2 · 3+ SYGNAŁY LUB SEN PONIŻEJ 6 H

Zadzwoń do lekarza w ciągu 48 h. Ogranicz dostęp do kart kredytowych — daj osobie zaufanej. Odwołaj duże decyzje (zakupy, kontrakty). Unikaj stymulujących sytuacji (imprezy, koncerty, podróże).

POZIOM 3 · BRAK SNU 2 NOCY LUB OBJAWY PSYCHOTYCZNE

Natychmiastowy kontakt z lekarzem — telefonicznie, nie czekaj na wizytę. Osoba bliska przejmując klucze do auta i karty płatnicze. Jeśli niedostępny lekarz — izba przyjęć psychiatryczna.

04 ☉ Plan działania — sygnały depresji

POZIOM 1 · 1–2 SYGNAŁY, ŁAGODNE

Utrzymaj rytm dobowy (nie przesypiaj). Codzienne 15 min ruchu na zewnątrz. Jedno przyjemne zaplanowane zajęcie dziennie. Trzy kontakty społeczne w tygodniu. Notuj wykres nastroju.

POZIOM 2 · 3+ SYGNAŁY LUB SPADEK FUNKCJONOWANIA

Skontaktuj się z lekarzem w ciągu tygodnia. Aktywacja behawioralna: minimalna lista zadań na dzień, zaplanowana z wieczora. Powiedz osobie bliskiej. Nie odstawiaj leków.

POZIOM 3 · MYŚLI REZYGNACYJNE LUB SAMOBÓJCZE

Natychmiastowy kontakt z lekarzem. Osoba bliska zostaje z Tobą. Telefon zaufania: **116 123** (dorośli) lub **116 111** (młodzież). Jeśli zagrożenie — pogotowie 112 lub izba przyjęć.

Klucz: w meta-analizie Morriss i wsp. (2007, Cochrane) psychoedukacja z planem sygnałów ostrzegawczych *obniżała czas do nawrotu manii o medianę 35 tygodni* w porównaniu z farmakoterapią bez psychoedukacji. Twoja lista jest dokumentem żywym — aktualizuj ją po każdym epizodzie, dodając nowe sygnały, które dopiero teraz rozpoznałeś/-am wstecznie.